



SIMULADO TEMI 2026

30 QUESTÕES — TODOS OS EIXOS TEMÁTICOS

*Sepse • VM/Desmame • Cardiologia Crítica • Neurointensivismo • Ácido-Base • Hemostasia • Infecção •
Sedação • SDRA • Ética*

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Preparação TEMI 2026 — Prova Teórica: 10/11/2026 | Prática: 15/11/2026 — Olinda/PE

GABARITO RÁPIDO — CONSULTA RÁPIDA

USE PARA CONFERÊNCIA APÓS REALIZAR O SIMULADO SEM CONSULTA

Q	R	Eixo	Q	R	Eixo	Q	R	Eixo
Q01	B	Sepse	Q11	E	Sepse	Q21	B	Sepse
Q02	C	VM	Q12	B	VM	Q22	B	Cardiologia Crítica
Q03	C	Cardiologia Crítica	Q13	C	Cardiologia Crítica	Q23	B	VM
Q04	B	Neurointensivismo	Q14	B	Neurointensivismo	Q24	B	Neurointensivismo
Q05	B	Ácido-Base	Q15	A	Ácido-Base	Q25	B	Ácido-Base
Q06	B	Hemostasia	Q16	C	Hemostasia	Q26	C	Hemostasia
Q07	C	Infecção	Q17	A	Infecção	Q27	C	Infecção
Q08	B	Sedação	Q18	B	Sedação	Q28	B	SDRA
Q09	B	SDRA	Q19	B	SDRA	Q29	C	Sedação
Q10	D	Ética	Q20	C	Ética	Q30	C	Ética

Distribuição por Eixo Temático

Eixo Temático	Questões	Números
Sepse/Choque	3	Q01, Q11, Q21
VM/Desmame	3	Q02, Q12, Q23
Cardiologia Crítica	3	Q03, Q13, Q22
Neurointensivismo	3	Q04, Q14, Q24
Ácido-Base/Eletrolíticos	3	Q05, Q15, Q25
Hemostasia/Transusão	3	Q06, Q16, Q26
Infecção/Antibióticos	3	Q07, Q17, Q27
Sedação/Analgesia/Delirium	3	Q08, Q18, Q29
SDRA/BNM	3	Q09, Q19, Q28
Ética/Bioética	3	Q10, Q20, Q30

QUESTÕES COMENTADAS — SIMULADO COMPLETO

QUESTÃO 01 | Sepses — Bundle 1h (SSC 2021)

Eixo: Sepses/Choque

Dificuldade: Média

Paciente de 68 anos admitido com pneumonia comunitária grave. FC 118 bpm, FR 28 irpm, PA 88/56 mmHg, temperatura 39,2°C, confusão mental. Lactato arterial: 3,2 mmol/L. Glasgow 12. Qual é a ação que tem o MAIOR impacto na mortalidade neste paciente dentro da 1ª hora?

A) Solicitar tomografia de tórax para confirmar o foco infeccioso antes de antibióticos

B) Coletar hemocultura (2 pares) E iniciar antibiótico de amplo espectro dentro de 1 hora

C) Iniciar noradrenalina 0,1 mcg/kg/min para atingir PAM $\geq$ 65 mmHg imediatamente

D) Administrar 30 mL/kg de cristalóide em 3h como bundle sepsis obrigatório

E) Dosar procalcitonina e aguardar resultado para guiar antibioticoterapia

✓ **Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: Sepses/Choque**

Bundle Sepsis SSC 2021 — elemento de maior impacto: antibióticos em < 1 hora. Kumar et al. (CCM 2006): cada hora de atraso no antibiótico aumenta mortalidade 7%. A coleta de hemoculturas ANTES do antibiótico é obrigatória (não adia o início). Noradrenalina: indicada se PAM < 65 após ressuscitação volêmica adequada. Bundle 30 mL/kg foi revisado — recomendação atual: ressuscitação guiada por marcadores de perfusão (lactato, PAM), não volume fixo. PCT: guia descontinuação, não início.

QUESTÃO 02 | VM Protetora — SDR (ARDSNet)

Eixo: VM/Desmame

Dificuldade: Fácil

Paciente com SDR moderado (P:F = 180 mmHg). Em modo VCV, peso predito 70 kg. Parâmetros atuais: VT 550 mL, FR 18 irpm, PEEP 8 cmH₂O, FiO₂ 0,60. Pressão de platô 32 cmH₂O, driving pressure 24 cmH₂O. Qual é o ajuste mais importante a realizar AGORA?

A) Aumentar PEEP para 14 cmH₂O para melhorar oxigenação

B) Reduzir VT para 490 mL (7 mL/kg PPI) para atingir VT $\leq$ 6 mL/kg PPI

C) Reduzir VT para 420 mL (6 mL/kg PPI) e aceitar hipercapnia permissiva

D) Aumentar FR para 24 irpm para compensar a redução do VT

E) Manter parâmetros atuais — platô < 35 cmH₂O é aceitável

✓ **Resposta: C | Dificuldade: Fácil | Eixo: VM/Desmame**

ARDSNet (NEJM 2000): VT $\leq$ 6 mL/kg do peso predito ideal (PPI) — mortalidade reduzida de 39,8% para 31,0%. PPI = $50 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$ para homens. Peso predito 70 kg $\rightarrow$ VT alvo 420 mL (6 mL/kg). Driving pressure 24 cmH₂O é muito alta (alvo < 15 cmH₂O — Amato NEJM 2015). Platô 32 cmH₂O está próximo do limite (< 30 cmH₂O ideal). A redução do VT é a intervenção de maior benefício comprovado. Hipercapnia permissiva (PaCO₂ 50-60) é aceitável para alcançar VT protetor.

QUESTÃO 03 | ECMO-VA — Complicação

Eixo: Cardiologia Crítica

Dificuldade: Difícil

Paciente em ECMO-VA periférica por choque cardiogênico pós-IAM anterior. SpO₂ do oxímetro no MMII = 99%. Gasometria de artéria radial direita: PaO₂ = 46 mmHg, SatO₂ 70%. FiO₂ do ventilador = 1,0. O que está ocorrendo e qual é a conduta?

A) Falha do oxigenador ECMO — trocar circuito imediatamente

B) Pneumotórax hipertensivo — descompressão imediata

C) Síndrome de Arlequin — otimizar ventilação e/ou reposicionar cânula arterial

D) Trombose do cateter arterial radial — retirar cateter e fazer gasometria venosa

E) Hiperoxia nos membros inferiores — reduzir FiO2 da ECMO

✔ **Resposta: C | Dificuldade: Difícil | Eixo: Cardiologia Crítica**

Síndrome de Arlequim (North-South syndrome): sangue retorna pela artéria femoral em direção cefálica. Se o VE ejeta sangue hipoxêmico (pulmões comprometidos), mistura-se ao sangue ECMO na aorta descendente. SpO2 femoral = 99% (sangue ECMO). Gasometria radial direita = hipóxia (sangue nativo hipoxêmico atinge coronárias e cérebro). Conduta: (1) otimizar ventilação para oxigenar pulmão nativo (↑ PEEP, FiO2 VM), (2) avançar cânula de retorno para aorta proximal, (3) adicionar cânula venosa jugular (ECMO híbrida VAV). Monitorar SEMPRE SpO2 da mão direita em ECMO-VA periférica.

QUESTÃO 04 | HSA — Nimodipina e Vasoespasmo

Eixo: Neurointensivismo

Dificuldade: Média

Mulher de 48 anos, HSA grau III (WFNS), aneurisma da ACM embolizado no 2º dia. No 7º dia, piora do nível de consciência. Doppler transcraniano: VMCA esquerda = 195 cm/s (basal = 80 cm/s). AngioTC: vasoespasmo moderado-grave. Ela estava em uso de nimodipina 60 mg q4h. O próximo passo mais correto é:

A) Suspende nimodipina — causou vasodilatação paradoxal piora o vasoespasmo

B) Manter nimodipina + elevar PA com noradrenalina (hipertensão induzida) + considerar angioplastia química se refratário

C) Iniciar Triple H: hipertensão + hipervolemia + hemodiluição

D) Repetir embolização do aneurisma — ressangramento é a causa mais provável

E) Dexametasona IV — edema cerebral por vasoespasmo

✔ **Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: Neurointensivismo**

Nimodipina: manter (único fármaco com evidência de melhora de desfecho em HSA — Pickard 1989). Reduz isquemia tardia, NÃO previne vasoespasmo arteriográfico. Conduta para DCI (Delayed Cerebral Ischemia): (1) nimodipina contínua, (2) euvolemia/hipertensão induzida (elevar PA 20-40 mmHg acima basal com nora), (3) angioplastia química (papaverina/nicardipina intra-arterial) OU mecânica se refratária. Triple H foi abandonado — hipervolemia sem evidência e aumenta risco de complicações. Ressangramento: causa mais comum é nos primeiros dias, após embolização o risco é muito menor.

QUESTÃO 05 | Distúrbio Misto — Interpretação

Eixo: Ácido-Base/Eletrolíticos

Dificuldade: Difícil

Gasometria arterial: pH 7,38, pCO2 50 mmHg, HCO3 29 mEq/L, Na 140, Cl 90, albumina 3,5 g/dL. Lactato 1,2 mmol/L. A interpretação mais completa deste exame é:

A) Acidose respiratória crônica compensada — DPOC estável

B) Acidose respiratória crônica + alcalose metabólica — distúrbio misto

C) Alcalose metabólica pura por hipocloremia (Cl 90) — uso de diurético

D) Normal — pH, pCO2 e HCO3 dentro dos limites normais

E) Acidose metabólica com AG elevado + acidose respiratória — distúrbio misto

✔ **Resposta: B | Dificuldade: Difícil | Eixo: Ácido-Base/Eletrolíticos**

Passo a passo: (1) pH 7,38 — normal/limítrofe. (2) pCO2 50 — acidose respiratória primária. (3) Compensação esperada para acidose resp. crônica: HCO3 sobe 3,5 mEq/L por 10 mmHg pCO2. pCO2 subiu 10 mmHg → HCO3 esperado $24 + 3,5 = 27,5$ mEq/L. HCO3 real = 29 > 27,5 = HCO3 acima do esperado. (4) Diagnóstico: acidose respiratória crônica (DPOC) + alcalose metabólica superposta (hipocloremia Cl 90 — uso de diuréticos ou vômitos). (5) AG: $140 - (90 + 29) = 21$ → AG corrigido albumina: $21 - 0,5 = 20,5$ — elevado. Espera-se AG baixo na alcalose. Aqui AG elevado sugere também processo oculto (ou limitação da fórmula com hipocloremia). A resposta B identifica o distúrbio primário + superposto.

QUESTÃO 06 | TIH — Score e Conduta

Eixo: Hemostasia/Transfusão

Dificuldade: Média

Paciente no 8º dia pós-cirurgia abdominal. Recebeu heparina profilática SC desde o 1º dia. Plaquetas: D0=220k / D7=180k / D8=88k (queda de 51%). Novo evento: TVP femoral confirmada por Doppler. Sem outros motivos para queda plaquetária. Score 4T = 7. Qual é a conduta CORRETA?

A) Trocar heparina SC para enoxaparina em dose terapêutica — HBPM tem menos cross-reatividade

B) Suspende heparina + iniciar argatrobana IV com TTPA alvo 1,5-3x basal

C) Transfundir plaquetas para manter > 100k antes de qualquer intervenção

D) Aguardar resultado do anticorpo HIT (ELISA) antes de qualquer mudança — evitar anticoagulação excessiva

E) Iniciar warfarina imediatamente — transição segura da heparina

✓ Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: Hemostasia/Transfusão

Score 4T = 7 (alto risco — probabilidade TIH > 80%). Conduta imediata: SUSPENDER TODA HEPARINA (incluindo HBPM — cross-reatividade 10-30%). Iniciar anticoagulante alternativo SEM aguardar ELISA (demora 24-48h, risco trombótico imediato). Argatrobana (1ª escolha — eliminação hepática, segura em IR) com alvo TTPA 1,5-3x basal. Enoxaparina: CONTRAINDICADA em TIH. Transfusão de plaquetas: evitar em TIH — pode piorar trombose ('fuel on the fire'). Warfarina: contraindicada na fase aguda de TIH (pode causar necrose cutânea e trombose venosa de membros — síndrome de coumarin-induced necrosis via depleção de proteína C).

QUESTÃO 07 | PK/PD — Beta-lactâmico e MIC

Eixo: Infecção/Antibióticos

Dificuldade: Difícil

Pseudomonas aeruginosa isolada em BAL de paciente com PAV. MIC ao meropeném = 4 mg/L (sensível-intermediário). O microbiologista recomenda 'otimizar a estratégia PD'. O parâmetro farmacodinâmico-alvo para o meropeném e a melhor estratégia posológica são:

A) $C_{max}/MIC \geq 10$ — aumentar dose para 3g q8h em bolus rápido

B) $AUC/MIC \geq 400$ — meropeném 1g q6h para aumentar frequência

C) $T > MIC \geq 100\%$ — meropeném 2g IV em infusão de 3h a cada 8h

D) $T > MIC \geq 40\%$ — meropeném 500 mg q6h é suficiente para MIC 4

E) C_{max}/MIC — trocar para amicacina 20 mg/kg q24h como alternativa

✓ Resposta: C | Dificuldade: Difícil | Eixo: Infecção/Antibióticos

Beta-lactâmicos são tempo-dependentes. O parâmetro PD crítico é $T > MIC$ (tempo acima da MIC). Para bactérias com MIC elevada (zona intermediária), a meta é $T > MIC \geq 100\%$ do intervalo — infusão estendida ou contínua. Meropeném 2g em 3h q8h: mantém concentração acima da MIC por todo o intervalo. Monte Carlo simulations (Andes 2002, DALI trial 2014): infusão estendida aumenta probabilidade de atingir $T > MIC$ em Pseudomonas com MIC 4. Bolus rápido: $T > MIC$ cai rapidamente após pico alto (ineficaz para MIC elevada). Aminoglicosídeos: parâmetro C_{max}/MIC — não substituem carbapenem neste contexto.

QUESTÃO 08 | aBCDEF Bundle — Protocolo SAT/SBT

Eixo: Sedação/Analgesia/Delirium

Dificuldade: Média

Paciente em VM há 3 dias por exacerbação de DPOC. RASS atual -3 (sedação profunda com propofol). Dor controlada (CPOT = 1). Hemodinâmica estável: PA 128/78, FC 82. Sem agitação. Screening diário: causa da VM controlada, FiO2 0,35, PEEP 5. Próxima etapa do bundle aBCDEF:

A) Manter sedação profunda (RASS -3) — previne auto-extubação acidental

B) Realizar SAT (Spontaneous Awakening Trial) — suspender sedação temporariamente e reavaliar

C) Aumentar propofol para RASS -4 — maior sedação melhora adaptação ao ventilador

D) Iniciar benzodiazepínico adicional — propofol isolado é insuficiente para DPOC

E) Aguardar 7 dias de VM antes de tentar reduzir sedação

✓ Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: Sedação/Analgesia/Delirium

Protocolo aBCDEF (SCCM PADIS 2018): o 'B' inicial (antes do SBT) é o SAT — Spontaneous Awakening Trial. Girard et al. (Lancet 2008): SAT + SBT coordenados = menos VM (-3 dias), menos delirium, melhora mortalidade 1 ano. SAT: suspender toda sedação (manter analgesia), avaliar RASS a cada 30 min por 4h. Critérios de falha SAT: agitação grave, SpO₂ < 88%, FR > 35, desconforto óbvio. Se SAT passado: SBT imediato. Sedação profunda sem indicação específica (SDRA grave, BNM) = prática que aumenta dias de VM, delirium e mortalidade.

QUESTÃO 09 | SDRA — Pronação

Eixo: SDRA/BNM

Dificuldade: Média

Paciente com SDRA grave: P:F = 110 mmHg após 24h com PEEP 10 e VT 6 mL/kg PPI. FiO₂ 0,80. Driving pressure 18 cmH₂O. Ele está sedado com RASS -4, em decúbito dorsal. Qual é a conduta prioritária agora?

A) Aumentar PEEP para 16 cmH₂O para recrutar alvéolos

B) Iniciar cisatracúrio 48h e colocar o paciente em posição prona por 16h

C) Adicionar ECMO-VV — SDRA grave refratário

D) Aumentar FiO₂ para 1,0 e tolerar hipercapnia de 80 mmHg

E) Manobra de recrutamento alveolar: CPAP 40 cmH₂O por 40 segundos

✓ Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: SDRA/BNM

SDRA grave (P:F < 150) após 12-24h de VM otimizada = indicação Classe I de pronação (PROSEVA trial, NEJM 2013). PROSEVA: prona 16h/dia → mortalidade 16% vs 33% (NNT = 6). Conduta correta: cisatracúrio (BNM para prevenir assincronia na prona) + prona imediata por 16h. Aumentar PEEP: sem evidência de benefício isolado em SDRA grave (EPVent2 negativo). ECMO-VV: indicação apenas se refratário à pronação (P:F < 80 após prona + VM otimizada). Manobra de recrutamento: controversa — PHARLAP (NEJM 2019): recrutamento agressivo aumenta mortalidade.

QUESTÃO 10 | Morte Encefálica — CFM 2.173/2017

Eixo: Ética/Bioética

Dificuldade: Média

Paciente em coma aperceptivo pós-PCR anóxica, internado há 72h. Duas avaliações clínicas por médicos diferentes confirmaram ausência de todos os reflexos de tronco e apneia (PaCO₂ final = 62 mmHg sem esforço respiratório). Temperatura 36,8°C. Sem sedativos ativos (dosagem plasmática negativa). Para CONFIRMAR o diagnóstico de morte encefálica conforme CFM 2.173/2017, qual é o próximo passo obrigatório?

A) Terceira avaliação clínica por médico com especialidade em neurologia

B) TC de crânio evidenciando anoxia difusa e apagamento dos sulcos

C) EEG mostrando silêncio elétrico cortical (flat line)

D) Qualquer um dos seguintes: EEG silêncio elétrico OU DTC sem fluxo OU angiografia sem enchimento intracraniano OU cintilografia sem captação

E) Aguardar 24h adicionais de observação clínica para confirmar irreversibilidade

✓ Resposta: D | Dificuldade: Média | Eixo: Ética/Bioética

CFM 2.173/2017: após 2 avaliações clínicas com intervalo adequado (para > 2 anos: 1h) confirmando coma aperceptivo + ausência de reflexos tronco + apneia (PaCO₂ ≥ 55 mmHg), é OBRIGATÓRIO um exame complementar. Opções aceitas: EEG (silêncio elétrico), Doppler transcraniano (ausência fluxo diastólico ou reverso), angiografia cerebral (sem enchimento), cintilografia (sem captação), potencial evocado de tronco. TC de crânio: mostra dano estrutural mas NÃO confirma ausência de atividade funcional — NÃO é exame aceito para ME. Não é necessária terceira avaliação clínica.

QUESTÃO 11 | Vasopressores — Choque Distributivo Refratário

Eixo: Seps/Choque

Dificuldade: Difícil

Paciente com sepse por *Klebsiella* KPC. Noradrenalina 0,8 mcg/kg/min + vasopressina 0,04 U/min. PAM = 58 mmHg (meta ≥ 65). Lactato 5,2 mmol/L em ascensão. FC 115 bpm. Ecocardiograma: VE hiperdinâmico, sem derrame. FE 72%. Próxima droga a adicionar:

- A) Dopamina 5 mcg/kg/min — aumentar tônus dopaminérgico renal
- B) Adrenalina 0,1 mcg/kg/min — aumentar tônus vasopressor e inotropia
- C) Dobutamina 5 mcg/kg/min — VE pode ter disfunção oculta
- D) Azul de metileno 2 mg/kg IV — choque vasoplégico refratário aos vasopressores clássicos

E) Hidrocortisona 200 mg/dia IV — insuficiência adrenal relativa**✓ Resposta: E | Dificuldade: Difícil | Eixo: Seps/Choque**

Choque séptico refratário a 2 vasopressores (noradrenalina + vasopressina) em dose alta = indicação de hidrocortisona (APROCCHSS trial, NEJM 2018: hidrocortisona + fludrocortisona → menos choque refratário, menos óbito em alguns subgrupos). Dose: 200 mg/dia IC ou 50 mg q6h. VE hiperdinâmico = sem disfunção sistólica — dobutamina não indicada. Dopamina: mais arritmias (SOAP II). Adrenalina: opção mas piora acidose láctica (elevação de lactato por efeito beta2 — SOAP II). Azul de metileno: usado em choque refratário após CRM ou anafilaxia, não como padrão em sepse. Hidrocortisona: primeiro passo em choque dependente de vasopressor alto.

QUESTÃO 12 | SBT — Índice de Tobin

Eixo: VM/Desmame

Dificuldade: Média

Após SAT bem-sucedido (RASS 0, sem agitação), paciente realiza PSV 5/PEEP 5 por 30 minutos. FR = 24 irpm, VT = 380 mL (0,38 L), SpO₂ 95%, FC 92 bpm, sem uso de musculatura acessória. Índice de Tobin calculado e conduta:

- A) $f/VT = 24/380 = 0,063$ → Falha do SBT → retornar VM com parâmetros anteriores
- B) $f/VT = 24/0,38 = 63$ rpm/L → Sucesso do SBT → preparar para extubação**
- C) $f/VT = 24/0,38 = 63$ → Zona cinza (60-80) → estender SBT para 2h antes de decidir
- D) SBT com PSV 5 é mais exigente que T-piece → repetir em T-piece antes de extubar
- E) Índice de Tobin não se aplica após SAT — apenas após sedação suspensa por 24h

✓ Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: VM/Desmame

$f/VT = FR \text{ (rpm)} \div VT \text{ (LITROS)}$. FR = 24, VT = 380 mL = 0,38 L. $f/VT = 24/0,38 = 63$ rpm/L. < 80 = alta probabilidade de sucesso (sensibilidade 97% — Yang & Tobin NEJM 1991). Todos os critérios clínicos do SBT também passam: SpO₂ $\geq 90\%$, FC < 140 , sem acessório, sem agitação. Conduta: extubação com planejamento (presença de médico, material de reintubação, considerar VNI profilática se DPOC). Erro clássico: usar VT em mL → $f/VT = 0,063$ (absurdo biologicamente — armadilha clássica de prova). PSV 5/PEEP 5 é equivalente ao T-piece (Brochard 1994) — não precisa repetir.

QUESTÃO 13 | FA + WPW — Antiarrítmico

Eixo: Cardiologia Crítica

Dificuldade: Média

Homem de 31 anos, palpitações e síncope pré-síncope. FC 210 bpm, BP 96/64. ECG: ritmo irregular, QRS largos e variáveis (200-400 ms), sem ondas P visíveis, intervalo RR mínimo 220 ms. Histórico: pré-excitação no ECG de rotina há 2 anos. Conduta MAIS SEGURA:

- A) Adenosina 6 mg IV rápido — bloqueia o nó AV e reverte para ritmo sinusal
- B) Diltiazem 0,25 mg/kg IV — controle de frequência urgente
- C) Cardioversão elétrica sincronizada 200J imediata**
- D) Amiodarona 150 mg IV em 10 min — mais seguro que cardioversão

E) Digoxina 0,5 mg IV — digital controla FA com WPW eficazmente

✓ **Resposta: C | Dificuldade: Média | Eixo: Cardiologia Crítica**

FA com pré-excitação (WPW): CONTRAINDICADOS adenosina, diltiazem, verapamil, digoxina, amiodarona. Todos bloqueiam o nó AV → condução preferencial pela via acessória → pode atingir 300-400/min → FV e morte. Intervalo RR < 250 ms = via acessória com período refratário curto = alto risco. Instável (síncope/PA limítrofe) → **CARDIOVERSÃO ELÉTRICA IMEDIATA**. Estável com WPW: procainamida 17 mg/kg IV em 25-50 min (bloqueia a via acessória). Amiodarona: relativamente contraindicada em WPW+FA (encurtamento PRE da via acessória descrito).

QUESTÃO 14 | HIC — Escada Terapêutica

Eixo: Neurointensivismo

Dificuldade: Difícil

TCE grave (GCS 6 pós-IOT). DVE implantado: PIC = 30 mmHg. PAM = 92 mmHg. PPC = 62 mmHg. Cabeceira 30°, normocapnia, sedação (propofol), normotermia já realizados. Drenagem de 10 mL de LCR → PIC cai para 24 mmHg, mas em 20 min retorna a 30 mmHg. Próximo passo da escada terapêutica:

A) Hiperventilação agressiva: PaCO₂ alvo 28 mmHg — vasoconstrição cerebral imediata

B) Manitol 20% 1 g/kg IV em 15 min OU SF 7,5% 150 mL IV em 20 min

C) Craniectomia descompressiva — PIC refratária a medidas de base

D) Barbitúrico coma: tiopental 5 mg/kg bólus → 1-3 mg/kg/h IC

E) Aumentar PAM para 110 para elevar PPC > 80 mmHg

✓ **Resposta: B | Dificuldade: Difícil | Eixo: Neurointensivismo**

Escada HIC (Berlin 2015): Nível 1 (base feitas), Nível 2 (sedação feita), Nível 3 (drenagem LCR feita — efeito temporário), PRÓXIMO → Nível 4: Terapia HIPEROSMOLAR. Manitol 20% 0,25-1 g/kg em 15 min (osmolalidade alvo < 320 mOsm/L) OU SF hipertônico 7,5% 150 mL (meta Na 145-155 se necessário). Hiperventilação (PaCO₂ 28): SOMENTE como resgate temporário (máx 30 min — causa isquemia cerebral). Craniectomia: nível 8 — último recurso. Barbitúrico: nível 6. PPC > 80: meta atual 60-70, forçar PAM alto pode piorar autoregulação.

QUESTÃO 15 | DKA — Insulina e K+

Eixo: Ácido-Base/Eletrolíticos

Dificuldade: Média

DKA grave: glicemia 520 mg/dL, pH 7,12, HCO₃ 7 mEq/L, K⁺ = 6,8 mEq/L. ECG sem alterações agudas. Qual é a conduta correta sobre insulina e potássio?

A) Iniciar insulina imediatamente (0,1 U/kg/h IC) — hipercalemia será corrigida pela insulina

B) Iniciar insulina apenas após K⁺ < 5,5 mEq/L — hipercalemia é contraindicação relativa

C) Iniciar insulina agora + monitorar K⁺ de perto — hipercalemia de DKA é pseudohipercalemia

D) NÃO iniciar insulina IC — apenas insulina SC a cada 4h em DKA moderada

E) Corrigir bicarbonato antes da insulina — pH < 7,2 é contraindicação à insulina

✓ **Resposta: A | Dificuldade: Média | Eixo: Ácido-Base/Eletrolíticos**

Na DKA, K⁺ inicial é FREQUENTEMENTE ELEVADO mesmo com estoques corporais depletados (redistribuição celular por acidose). Com K⁺ = 6,8 e ECG SEM alterações: iniciar insulina imediatamente (0,1 U/kg/h). A insulina vai REDUZIR o K⁺ ao distribuí-lo intracelularmente — isso é desejável quando K⁺ está alto. ATENÇÃO: a regra de NÃO iniciar insulina é com K⁺ < 3,5 (hipocalemia = risco de arritmia quando insulina redistribui K⁺ para dentro). Com K⁺ > 5,5: iniciar insulina + monitorar K⁺ agressivamente (a cada 1-2h) — o K⁺ vai cair rapidamente e pode precisar de reposição nas próximas horas. Bicarbonato: controverso em pH > 6,9 — não indicado aqui.

QUESTÃO 16 | CIVD — Tratamento

Eixo: Hemostasia/Transfusão

Dificuldade: Difícil

Parturiente com descolamento prematuro de placenta. Sangramento uterino maciço intraoperatório. Lab: plaquetas 35.000, fibrinogênio 80 mg/dL, INR 2,3, TTPA 2x, D-Dímero 45 µg/mL. Score ISTH = 7 (CIVD declarada). Qual é a terapia mais crítica a iniciar IMEDIATAMENTE além da reposição cirúrgica da causa?

- A) Heparina sódica IV 5000 U — anticoagular a CIVD trombótica
- B) Crioprecipitado 10 U IV + PFC 15 mL/kg + plaquetas para elevar fibrinogênio e fatores
- C) Ácido tranexâmico 1g IV — bloquear fibrinólise em CIVD hemorrágica obstétrica**
- D) Proteína C ativada (Xigris) — anti-inflamatório na CIVD séptica
- E) Desmopressina (DDAVP) 0,3 mcg/kg IV — liberar fator de von Willebrand

✓ **Resposta: C | Dificuldade: Difícil | Eixo: Hemostasia/Transfusão**

CIVD obstétrica + hemorragia maciça: o componente de fibrinólise hiperfibrinolítica é proeminente nesta situação. TXA (ácido tranexâmico) 1g IV em 10 min é indicado IMEDIATAMENTE em hemorragia pós-parto (WOMAN trial, Lancet 2017: reduz mortalidade por hemorragia 19%). Além do TXA: repor fibrinogênio (< 200 mg/dL → crioprecipitado ou fibrinogênio concentrado), PFC, plaquetas. Mas a opção B, embora correta como suporte hemoterápico, não aborda o mecanismo fisiopatológico primário da CIVD obstétrica (fibrinólise). Heparina em CIVD com SANGRAMENTO ATIVO = CONTRAINDICADA (usada apenas na CIVD trombótica sem sangramento). Drotrecogina (Xigris): retirada do mercado por ausência de benefício (PROWESS-SHOCK).

QUESTÃO 17 | Candidemia — Protocolo

Eixo: Infecção/Antibióticos

Dificuldade: Média

Paciente em UTI há 15 dias, NPT há 8 dias, antibióticos de amplo espectro, CVC duplo lúmen. Nova febre + hemocultura positiva para *Candida tropicalis*. Você iniciou micafungina 100 mg/dia. Quais ações adicionais são OBRIGATÓRIAS nas próximas 24h? Assinale a MAIS COMPLETA:

- A) Solicitar fundoscopia + ecocardiograma se suspeita endocardite + considerar retirada do CVC**
- B) Apenas aguardar antibiograma antes de qualquer decisão adicional
- C) Trocar micafungina para fluconazol 800 mg — espectro mais amplo para *C. tropicalis*
- D) Repetir hemocultura apenas após 7 dias para confirmar negativação
- E) Aumentar micafungina para 150 mg — dose padrão para *C. tropicalis*

✓ **Resposta: A | Dificuldade: Média | Eixo: Infecção/Antibióticos**

Candidemia documentada — medidas obrigatórias: (1) FUNDOSCOPIA < 7 dias (endoftalmite em 2-9% das candidemias, assintomática, muda duração do tratamento). (2) RETIRADA DO CVC (ou troca sobre fio) — biofilme de *Candida* no cateter é reservatório, manutenção = bacteremia persistente e maior mortalidade. (3) ECOCARDIOGRAMA se fatores de risco para endocardite. (4) Hemocultura diária até negativação (não esperar 7 dias). Micafungina 150 mg: correto para *C. tropicalis*, mas a opção A aborda as obrigações de manejo integral. Fluconazol para *C. tropicalis*: pode ter sensibilidade reduzida — aguardar antibiograma. *C. tropicalis* tem maior resistência a azóis que *C. albicans*.

QUESTÃO 18 | Delirium — CAM-ICU

Eixo: Sedação/Analgesia/Delirium

Dificuldade: Fácil

Paciente de 74 anos, pós-op de laparotomia, em VM, extubado há 2 dias. Hoje: agitado, tenta retirar acesso venoso, responde de forma incoerente, desorientado (ontem estava bem). CAM-ICU: Feature 1 (início agudo + flutuação) = positivo, Feature 2 (desatenção) = positivo, Feature 3 (consciência alterada — RASS +2) = positivo. Diagnóstico e conduta farmacológica MAIS ADEQUADA:

- A) Delirium hiperativo confirmado — haloperidol 2,5 mg IV q8h + benzodiazepínico noturno

B) Delirium hiperativo confirmado — haloperidol 2,5-5 mg IV se necessário (restrição ao agudo) + tratar causa + medidas não farmacológicas

C) Agitação pós-op normal — lorazepam 1 mg IV para sedar

D) Síndrome de abstinência alcoólica — diazepam ou lorazepam titulado pelo CIWA

E) Psicose aguda — quetiapina 25 mg VO 2x/dia — antipsicótico atípico superior ao haloperidol

✓ **Resposta: B | Dificuldade: Fácil | Eixo: Sedação/Analgesia/Delirium**

CAM-ICU positivo com Features 1+2+3 = DELIRIUM HIPERATIVO confirmado. Tratamento: (1) BUSCAR E TRATAR CAUSA (dor — CPOT, hipóxia, constipação, retenção urinária, privação sono, polimedicação). (2) Medidas não farmacológicas (reorientação, mobilização precoce, iluminação, família). (3) Haloperidol IV 2,5-5 mg: para controle de agitação AGUDA perigosa (risco de retirar cateter, quedas). PADIS 2018: antipsicóticos NÃO reduzem duração do delirium ou mortalidade (MIND-USA trial) — usar com parcimônia para segurança, não como rotina. Benzodiazepínico: PIORA delirium (exceto síndrome de abstinência). Lorazepam sozinho: contraindicado — aprofunda delirium. Quetiapina: evidência insuficiente para rotina.

QUESTÃO 19 | BNM — TOF e Indicação

Eixo: SDRA/BNM

Dificuldade: Difícil

Paciente com SDRA moderado-grave, em prona há 8h, P:F = 140 mmHg. Cisatracúrio em IC. Monitor TOF: 0/4 twitches (sem resposta). FiO2 0,65. Driving pressure 16 cmH2O. Ausência de assincronia. Qual é a avaliação mais correta sobre o nível de bloqueio e conduta?

A) TOF 0/4 é o alvo ideal para SDRA em prona — manter dose atual

B) TOF 0/4 representa bloqueio excessivo — reduzir dose de cisatracúrio (alvo 1-2/4)

C) TOF 0/4 indica dose insuficiente — apenas bloqueio completo garante sincronia

D) Suspende cisatracúrio — BNM > 24h já aumenta risco de miopatia

E) Trocar cisatracúrio para rocurônio — mais potente na prona

✓ **Resposta: B | Dificuldade: Difícil | Eixo: SDRA/BNM**

ACURASYS (NEJM 2010) e protocolos SDRA: o alvo de BNM durante a infusão contínua é TOF 1-2/4 (bloqueio ~90%), NÃO TOF 0/4. TOF 0/4 = bloqueio excessivo (> 95%) — aumenta risco de miopatia da UTI (especialmente se associado a corticoides). Reduzir dose para atingir 1-2/4. ROSE trial (NEJM 2019): sedação profunda sem BNM = outcomes similares ao ACURASYS, sugerindo que a sedação profunda (não o BNM per se) pode ser o mecanismo. Cisatracúrio: não substituir por rocurônio (cisatracúrio tem eliminação de Hofmann — ideal em IRA; rocurônio acumula).

QUESTÃO 20 | LSV — Limitação do Suporte de Vida

Eixo: Ética/Bioética

Dificuldade: Média

Paciente de 82 anos com câncer de pâncreas metastático, performance status 4 (ECOG), admitido por pneumonia. Família solicita 'tudo que for possível'. Sem diretiva antecipada de vontade. Médico avalia: prognóstico reservado, qualidade de vida muito comprometida, sem perspectiva de alta. Qual é a conduta mais alinhada com a deontologia médica e a Resolução CFM 1.805/2006?

A) Implementar tudo o que for solicitado pela família — autonomia familiar é absoluta

B) IOT, RCP e UTI obrigatórios — abandono de paciente grave é crime

C) Discutir com a equipe multidisciplinar + família: propor LSV com foco em conforto, documentando no prontuário conforme CFM 1.805/2006

D) Registrar DNR sem discutir com família — decisão exclusivamente médica

E) Encaminhar ao comitê de ética hospitalar para toda decisão de LSV

✓ **Resposta: C | Dificuldade: Média | Eixo: Ética/Bioética**

CFM 1.805/2006: médico pode limitar ou suspender tratamentos que 'prolonguem a vida do doente em fase terminal' sem possibilidade razoável de cura, garantindo conforto e dignidade. A decisão é COMPARTILHADA

(médico + equipe + família + quando possível, paciente). O paciente sem DAV mas com performance PS 4 + neoplasia avançada + sem perspectiva de reversão: LSV com foco em cuidados paliativos é eticamente adequada e legalmente amparada. A família não pode impor tratamentos fúteis (autonomia familiar não é absoluta). Toda decisão deve ser registrada no prontuário com fundamentação clínica. Comitê de ética: recurso para conflitos, não para toda decisão de LSV.

QUESTÃO 21 | Sepses — SOFA Score

Eixo: Sepses/Choque

Dificuldade: Média

Paciente com pneumonia grave. SOFA calculado: Glasgow 13 (1 pt), PAM 62 com nora 0,1 (3 pts), creatinina 2,1 mg/dL (2 pts), bilirrubina 1,3 mg/dL (0 pt), plaquetas 95k (1 pt), PaO₂/FiO₂ 220 (2 pts). SOFA total = 9. O que este valor indica clinicamente?

A) SOFA 9 = sepsis leve — sem indicação de UTI

B) SOFA 9 = disfunção orgânica grave compatível com sepsis — mortalidade hospitalar estimada 40-60%

C) SOFA deve ser calculado apenas após 24h de internação — valor precoce não é válido

D) SOFA 9 indica necessidade de RRT (terapia renal substitutiva) imediata

E) SOFA não se aplica a pacientes fora da UTI

✓ Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: Sepses/Choque

Sepsis-3 (JAMA 2016): sepsis = infecção suspeita + disfunção orgânica (SOFA ≥ 2 acima do basal). SOFA 9 representa disfunção de múltiplos órgãos (respiratório, cardiovascular, renal, hematológico, neurológico). Mortalidade estimada por SOFA: SOFA 9-10 = ~40-50%. SOFA 11-14 = ~50-60%. SOFA > 14 = >80%. O SOFA guia prognóstico e intensidade do tratamento — paciente com SOFA 9 e sepsis precisa de UTI. SOFA pode ser calculado em qualquer momento. RRT: indicada por acidose, hipercalemia, oligúria refratária — não apenas pelo SOFA.

QUESTÃO 22 | Suporte Mecânico — IABP vs Impella

Eixo: Cardiologia Crítica

Dificuldade: Difícil

Paciente com STEMI anterior extenso submetido a ICP primária. Após ICP: FE 22%, IC 1,6 L/min/m², PAM 64 mmHg com noradrenalina 0,35 mcg/kg/min + dobutamina 8 mcg/kg/min, lactato 4,1 mmol/L subindo. SCAI D. Qual é a estratégia de suporte mais adequada neste momento?

A) Inserir IABP — padrão ouro para choque cardiogênico isquêmico (ESC 2023 Classe I)

B) Escalar para Impella CP (3,5-4 L/min) ou considerar ECMO-VA se deterioração

C) Aumentar dobutamina para 20 mcg/kg/min antes de considerar suporte mecânico

D) Adicionar levosimendan — sensibilizador de cálcio melhora inotropia sem aumentar O₂

E) Inserir IABP imediatamente + aguardar 24h para avaliar necessidade de Impella

✓ Resposta: B | Dificuldade: Difícil | Eixo: Cardiologia Crítica

SCAI D = deteriorando apesar de 2 drogas vasoativas. IABP-SHOCK II (NEJM 2012): IABP NÃO reduz mortalidade em CC + ICP. ESC 2023: IABP rebaixado para recomendação IIb (seletivo). Impella CP (3,5-4 L/min) fornece descarga ativa do VE e suporte hemodinâmico superior ao IABP. SCAI D: escalonamento para Impella CP é a recomendação atual (SCAI Consensus 2022). ECMO-VA se deterioração para SCAI E ou se Impella insuficiente. Dobutamina 20 mcg/kg/min: dose alta com risco de arritmia sem evidência de benefício adicional neste contexto. Levosimendan: sem evidência superior à dobutamina em CC agudo (SURVIVE trial).

QUESTÃO 23 | Extubação — Cuff Leak Test

Eixo: VM/Desmame

Dificuldade: Média

Paciente intubada há 5 dias, mulher, 65 anos. SBT de 30 min bem-sucedido (f/VT 71, sem critérios de falha). Cuff Leak Test: VT programado 500 mL, VT expirado com cuff desinsuflado = 380 mL. Diferença = 120 mL. A conduta mais correta é:

A) Extubar diretamente — f/VT < 80 indica alta probabilidade de sucesso

B) Considerar metilprednisolona 20 mg IV q4h por 12h antes da extubação + planejar extubação com VNI imediata se estridor

C) NÃO extubar — cuff leak < 110 mL é indicação absoluta de traqueostomia

D) Repetir cuff leak test após 2h — resultado pode variar

E) Extubar em posição sentada com broncodilatador inalatório profilático

✓ **Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: VM/Desmame**

Cuff Leak Test: diferença VT programado - VT expirado com cuff desinsuflado. Diferença < 110 mL ou < 15,5% do VT = alto risco de estridor pós-extubação (Maury et al., Weber et al.). Aqui: 120 mL — limítrofe mas acima de 110. Porém mulher + IOT > 36h = fatores de risco para estridor. Conduta prudente: metilprednisolona 20 mg IV q4h por 12h antes da extubação (Cheng 2006: NNT = 4 para estridor). Planejar extubação com VNI profilática à beira do leito. NÃO é indicação de traqueostomia. Adrenalina inalatória disponível se estridor pós-extubação.

QUESTÃO 24 | AVCH — INTERACT-2 vs ATACH-2

Eixo: Neurointensivismo

Dificuldade: Difícil

Homem de 61 anos, AVCH hipertensivo putamenal, 35 mL, GCS 12. PA na admissão = 195/110 mmHg. Admitido há 35 min. Sem anticoagulação. Qual é a meta de PA nas PRIMEIRAS 6 HORAS e o agente de escolha?

A) PA < 180/110 — manter PAS entre 160-180 para garantir PPC adequada

B) PA < 140 mmHg sistólica em 1 hora — nicardipina IV 5-15 mg/h (INTERACT-2)

C) PA < 110 mmHg sistólica — controle agressivo reduz expansão do hematoma (ATACH-2)

D) Aguardar 24h antes de tratar PA — hipotensão aguda piora o hematoma

E) Nitroprussiato 0,5-3 mcg/kg/min — vasodilatador de ação rápida para controle imediato

✓ **Resposta: B | Dificuldade: Difícil | Eixo: Neurointensivismo**

INTERACT-2 (NEJM 2013): PAS < 140 mmHg em 1h melhora desfecho funcional (mRS) — reduz expansão do hematoma. ATACH-2 (NEJM 2016): PAS < 110 = SEM benefício adicional + MAIS eventos renais adversos. Meta atual baseada em evidências: PAS 130-150 mmHg (consenso pós-INTERACT-2 e ATACH-2). Opção B é a mais próxima do evidence-based: meta PAS < 140. Nicardipina IV: 1ª escolha (titulação precisa, sem efeito vasodilatador cerebral). Nitroprussiato: CONTRAINDICADO em AVCH (causa vasodilatação cerebral → aumento PIC → piora HIC).

QUESTÃO 25 | Hipercalemia — Cálcio x Insulina

Eixo: Ácido-Base/Eletrolíticos

Dificuldade: Média

K⁺ = 7,2 mEq/L. ECG: onda sinusoidal, QRS 180 ms. Paciente anúrico. Qual é a SEQUÊNCIA CORRETA de tratamento?

A) Insulina + Glicose → Cálcio → Diálise

B) Cálcio → Insulina + Glicose → Diálise (urgente)

C) Bicarbonato → Cálcio → Insulina → Kayexalate

D) Kayexalate retal → Insulina → Diálise

E) Diálise imediata — única abordagem eficaz com ECG grave

✓ **Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: Ácido-Base/Eletrolíticos**

ECG grave (onda sinusoidal + QRS 180 ms) = instabilidade elétrica iminente (PCR). Sequência correta: (1) CÁLCIO IMEDIATO (gluconato de cálcio 10% 20 mL IV em 2-3 min): estabiliza membrana cardíaca em 1-3 min (sem baixar K⁺). (2) INSULINA + GLICOSE: redistribuição K⁺ intracelular (-0,5 a 1,5 mEq/L) em 15-30 min. (3) DIÁLISE URGENTE: único método de eliminar K⁺ rapidamente em anúrico. Kayexalate: início muito lento (horas) e risco de necrose intestinal — não usar em emergência com ECG grave. Bicarbonato: apenas se acidose real — efeito menor.

QUESTÃO 26 | TEP Maciço — Trombólise

Eixo: Hemostasia/Transfusão

Dificuldade: Média

Mulher de 49 anos, TEP confirmado por AngioTC (trombo bilateral em troncos principais). PA 76/48 mmHg, FC 128 bpm, SpO2 84% em VNI. Troponina e BNP elevados. Sem contraindicações à trombólise. Conduta:

A) Heparina NF 80 U/kg bólus + 18 U/kg/h IC — tratamento padrão e aguardar resolução

B) Alteplase 100 mg IV em 2h; manter heparina concomitante durante infusão de alteplase

C) Alteplase 100 mg IV em 2h; SUSPENDER heparina durante infusão; reiniciar sem bólus quando TTPA < 80s após 2-3h

D) CDT (cateter-directed therapy) — mais segura que sistêmica em instabilidade hemodinâmica

E) Embolectomia cirúrgica de urgência — gold standard no TEP maciço

✓ **Resposta: C | Dificuldade: Média | Eixo: Hemostasia/Transfusão**

TEP alto risco (PAS < 90 mmHg) sem contraindicações = trombólise sistêmica imediata (ESC 2019, Classe I). Protocolo: Alteplase 100 mg IV em 2h. SUSPENDER heparina DURANTE a alteplase (risco hemorrágico). Reiniciar heparina (sem bólus) 2-3h após alteplase quando TTPA < 80s. Opção B está errada — heparina não deve ser mantida concomitantemente. CDT: alternativa em TEP intermediário-alto ou falha/contraindicação à sistêmica — não é 1ª linha em instabilidade hemodinâmica grave. Cirurgia: alternativa quando trombólise falha ou há contraindicação absoluta.

QUESTÃO 27 | NDM vs KPC — Antibióticos

Eixo: Infecção/Antibióticos

Dificuldade: Difícil

Klebsiella pneumoniae isolada com KPC E NDM positivos por PCR multiplex. Resistente a todos os carbapenems, cefepime, piperacilina-tazobactam. Sensível apenas a polimixina B (MIC 0,5). Qual combinação oferece MAIOR atividade contra este patógeno duplo-resistente?

A) Ceftazidima-avibactam 2,5g q8h em monoterapia — cobre KPC e NDM

B) Meropeném 2g q8h em infusão estendida + polimixina B — sinergia comprovada

C) Aztreonam 2g q6h + ceftazidima-avibactam 2,5g q8h — combinação sinérgica para KPC+NDM

D) Cefiderocol 2g q8h em monoterapia — ativo contra todas carbapenemases

E) Colistina + tigeciclina — padrão para gram-negativo XDR

✓ **Resposta: C | Dificuldade: Difícil | Eixo: Infecção/Antibióticos**

KPC+NDM dupla carbapenemase: ceftazidima-avibactam em MONOTERAPIA não funciona (avibactam inibe KPC mas NDM a destrói). Estratégia sinérgica: avibactam inibe a KPC → 'protege' o aztreonam de ser destruído pela KPC; NDM NÃO destrói aztreonam (monobactâmico — resistente a MBL); aztreonam ativo contra NDM. Combinação aztreonam + ceftazidima-avibactam = cobertura dupla KPC+NDM. Cefiderocol: opção D — ativo contra ambas carbapenemases por mecanismo único (siderofórico), mas evidências em KPC+NDM são emergentes. Polimixina B isolada: atividade por MIC 0,5 mas toxicidade elevada e monoterapia subótima.

QUESTÃO 28 | SDRA — Definição e Fenótipos

Eixo: SDRA/BNM

Dificuldade: Média

Paciente de 55 anos, 72h após pneumonia grave por influenza, em VM com VT 6 mL/kg PPI, PEEP 10, FiO2 0,65. Rx tórax: infiltrado bilateral difuso. PaO2/FiO2 = 155 mmHg. Sem IC (BNP normal, sem congestão). A classificação de Berlim (2012) para este paciente e a importância prognóstica são:

A) SDRA leve (P:F 200-300) — mortalidade 27%, tratar conservadoramente

B) SDRA moderado (P:F 100-200) — mortalidade 32%, considerar prona se refratário após 24h

C) SDRA grave (P:F < 100) — mortalidade 45%, prona + BNM indicados imediatamente

D) IRpA hipoxêmica — SDRA exige P:F < 100 para o diagnóstico

E) Critérios de Berlim exigem TC de tórax para diagnóstico — Rx bilateral é insuficiente

✓ **Resposta: B | Dificuldade: Média | Eixo: SDRA/BNM**

Definição de Berlim (2012): SDRA exige início < 1 semana + infiltrado bilateral no Rx ou TC + ausência de causa cardíaca (ou pressão oclusão < 18 mmHg). Classificação por P:F (com PEEP ≥ 5): Leve 200-300 (mortalidade ~27%), Moderado 100-200 (mortalidade ~32%), Grave < 100 (mortalidade ~45%). P:F = 155 = MODERADO. Prona: indicada em grave (P:F < 150) após 12-24h de VM otimizada — não imediatamente no moderado sem refratariedade. Rx bilateral é suficiente para o diagnóstico (TC não obrigatória). Berlim substituiu a definição de AECC 1994 (que não estratificava por P:F com PEEP).

QUESTÃO 29 | Analgesia — Protocolo Analgesia-Primeiro

Eixo: Sedação/Analgesia/Delirium

Dificuldade: Média

Paciente em VM pós-laparotomia de urgência. RASS -4, CPOT = 5 (dor grave). Recebendo propofol IC sem opioide. Equipe considera 'sedação adequada'. O que está errado e qual a conduta baseada em evidências?

A) Nada está errado — RASS -4 significa que o paciente não sente dor

B) A sedação está profunda demais — reduzir propofol para RASS -2

C) Protocolo analgesia-primeiro (analgesosedação): adicionar fentanil IC e reduzir sedativo — dor causa agitação e sedação sem analgesia é ineficaz

D) Adicionar benzodiazepínico para potencializar sedação e reduzir CPOT

E) CPOT 5 indica delirium hiperativo — iniciar haloperidol

✓ **Resposta: C | Dificuldade: Média | Eixo: Sedação/Analgesia/Delirium**

PADIS 2018 (SCCM): paradigma analgesosedação. Dor é a causa mais comum de agitação e 'aparente necessidade de mais sedação'. CPOT ≥ 3 = dor significativa. Tratar dor PRIMEIRO → reduz necessidade de sedativo. Fentanil IC (opioide IV) para dor pós-operatória + reduzir propofol para meta RASS -1 a 0. RASS -4 com dor = paciente paralisado pela sedação mas com nocicepção ativa (SOFRIMENTO). Propofol NÃO tem propriedade analgésica — é sedativo puro. Benzodiazepínico: piora delirium e não trata dor. CPOT 5 = dor (não delirium).

QUESTÃO 30 | Testamento Vital — DAV e Conflito Familiar

Eixo: Ética/Bioética

Dificuldade: Difícil

Paciente de 79 anos com DPOC muito grave admitido por exacerbação grave. Apresenta Diretiva Antecipada de Vontade (DAV) registrada em cartório declarando: 'não desejo ventilação mecânica invasiva em situação de doença avançada sem perspectiva de reversão'. Família (cônjuge e filhos) solicita IOT e UTI. Paciente sem capacidade decisória atual (confusão mental por hipercapnia). Conduta médica mais correta segundo CFM 1.995/2012:

A) Seguir a vontade da família — cônjuge tem direito legal superior à DAV

B) IOT imediata — situação de emergência suspende qualquer diretiva antecipada

C) Respeitar a DAV: oferecer VNI como suporte não invasivo, cuidados paliativos intensivos e discutir com família o valor da autonomia do paciente

D) Aguardar decisão do comitê de ética — conflito familiar exige deliberação institucional

E) Aplicar DAV apenas se confirmada por dois neurologistas como irreversível

✓ **Resposta: C | Dificuldade: Difícil | Eixo: Ética/Bioética**

CFM 1.995/2012: a DAV representa a autonomia do paciente e prevalece sobre a vontade dos familiares quando não há conflito ético grave. DPOC muito grave em exacerbação = cenário compatível com a declaração do paciente. Conduta: respeitar a DAV + oferecer VNI (suporte não invasivo — dentro do limite declarado) + analgesia/sedação para conforto + suporte familiar e espiritual. IOT seria contrária à vontade expressa e documentada. Família deve ser INFORMADA e APOIADA, não tem poder de substituição da autonomia do paciente com DAV válida. Situação de emergência não suspende DAV válida — a DAV foi feita justamente para prever este cenário.

